



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نعام جميل جبرة جريس
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : مدينه نصر الاول
العنوان : -----
رقم البطاقة : 27412092501548 رقم التليفون : 01003391388
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 09-12-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: نعام جميل جبرة جريس
National ID: 27412092501548



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

٢٠١٩/٠٥ ٢٧٤١٢٠٩٢٥٠١٥٤٨
ربة منزل

أشقي مسيحية متروجة
صبري حلمي مئري عبدالمسيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٥/٢٢

١

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نعام
جميل جبره جريس
٢ شارع الحدود - عزبة الهجاة
مدينة نصر اول - القاهرة

٢٧٤١٢٠٩٢٥٠١٥٤٨
IA4442675

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الاصدار: 2023-5-25

جهة الاصدار: فرع القاهرة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والادرامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة السعيه .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) نعام جميل جبره بطاقة رقم 27412092501548
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ المطباعة: 2023-5-25

الموظف المختص
دينا عماد



مسلم 741262



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

اوراق السكك الحارث حفته الدوله



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name : نعام جميل جبره جرجس

Sex:

MDT form

3- Medical number:

83140298

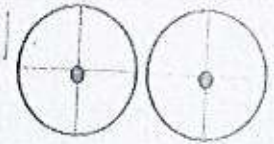
Old Med :

Old Med :

1624-2023

2-ID number: 27412092501548

Patient Age : 49 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01203359235

BMI

BMI

marital status

Marital Status

MARRIED

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Co morbidity

Co Morbidity

BRONCHIAL
ASTHMAMenopausal
statusMenopausal Status
POSTMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

Date of MDT

Date Of MDT

10/12/2023

Breast Imaging :

Clinical data

Mets Workup :
FREEBX
IDCER
7/8PR
4/8Her 2 Neu
3

SISH

KI67
3

BX COMMENT:

ER COMMENT:

PR COMMENT:

Her 2 Neu COMMENT:

SISH COMMENT:

T
3N
1M
0

Sonomammography

LT BREAST UOQ AND LOQ LITTLE EXTENT TO LIQ 4.5X2.5 CM

PATIENT HISTORY

received 6 cycles taxotere / carbo+4 cycles HP

ON EXAM AND BY REVIEWING MAMMOGRAM IMAGES THERE IS PROGRESSION IN BREAST MASS
It mrm

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

KADCYLA, E2 AND FSH, ZOLADEX, AI, PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

د/ حنان عزت

د/ رضوي صبره

RADIOLOGY

RADIOLOGY

د/ نيل حجازي

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition



Name: En'aam Gamil Gabra
Pat. Age: 45 Year(s)
Pat. ID: 1611674

Date: 06/05/2023

Dear Prof. Dr.:

Thank you for referring this case.:

MDCT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS WITH INTRAVENOUS CONTRAST (TRIPHASIC TECHNIQUE) :

- Known case of left breast cancer, the current study revealed:
- The liver shows mild enlarged size , fatty CT pattern , displaying homogeneous parenchymal density. No focal lesions.
- GB no dense stones, no mud , no masses .
- No evidence of dilated intra-hepatic biliary radicals detected.
- The spleen shows average in size displaying normal homogeneous CT density. No evidences of splenic masses or cysts detected.
- The pancreas shows average size displaying normal CT density. No evidences of pancreatic masses or cysts detected, clear peri-pancreatic fat planes.
- Both kidneys appear average in size displaying normal parenchymal appearance. No evidences of renal masses, stones, no back pressure changes detected, good excretory function seen
- Normal stomach, bowel loops with no apparent abnormalities .
- UB shows average wall thickening, no masses, no stones.
- Uterus and ovaries are of average size and shape with no masses nor cysts.
- No bony sclerotic or lytic bony deposits.
- Bilateral mild sacroiliitis .
- Transitional lumbo-sacral vertebra, partially sacralized L5 vertebra with right sided pseudoarthrosis .





سمارت سكان

للأشعة والرنين المغناطيسي

WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra
Pat. Age: 45 Year(s)
Pat. ID: 1611674

Date: 06/05/2023
Dear Prof. Dr.:
Thank you for referring this case.:

Opinion

- Known case of left breast cancer
- No evidence of any abdominal organ deposits.
- Fatty hepatomegaly.
- Bilateral mild sacroillitis .
- Transitional lumbo-sacral vertebra , partially sacralized L5 vertebra with right sided pseudoarthrosis .

Much Obligated, Yours
Dr. Islam Salah,MD



سمارت سكان

للأشعة والرنين المغناطيسي

WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Gamil Gabra
Pat. Age: 45 Year(s)
Pat. ID: 1611674

Date: 06/05/2023

Dear Prof. Dr.:

Thank you for referring this case.:

MDCT SCAN OF THE CHEST WITH CONTRAST REVEALED:-

- Known case of left breast cancer, the current study revealed:
- Left breast shows diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs , largest 22 mm .
- No pulmonary patches.
- No pulmonary consolidation, cavitary or infiltrative lesions.
- No pulmonary masses or sizeable nodules.
- Few basal linear thin atelectatic bands .
- No hilar or mediastinal masses or significant lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Patent trachea and major tracheo-bronchial airways.
- Intact bony thoracic cage.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No bony sclerotic or lytic bony deposits .

Opinion

- Known case of left breast cancer
- Left breast diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs .
- No evidence of any thoracic organ deposits .
- Few basal linear thin atelectatic bands .

Much Obliged, Yours
Dr. Islam Salah, MD



Baheya Accredited
By Joint Commission International



Baheya I M S Certified

بهيّة
بهيّة
مركز بهية للاكتشاف والمركز
وعلاج سرطان الثدي
مركز بهية للاكتشاف والمركز
وعلاج سرطان الثدي

PATIENT NAME: Naam GAMIL GABRA GRAS
GENDER: Female
AGE: 48 y

PATIENT ID #: 10123227128
ORDER #: 2349040
DATE OF SERVICE: 17-Jun-2023 04:02 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information: - skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP:

FINDINGS:

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Otherwise, no hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

18-Jun-2023 03:56 PM

PATIENT: Naam GAMIL GABRA GRAS, 10123227128, Female, 48 y

Report version 1, 20-Jun-2023 01:46 PM

Page 1 of 1





Patient Name : الأستاذة / نعام جميل جبره	Request No. : 13003964
Patient No. : 27412092501548	Request Date : 13/05/2023
Path No. : SR-577/23	Verification Date : 21/05/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross examination:

- Five slides labeled by (570007) slides were received.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma, micropapillary type.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+ 1)
- * DCIS: Focal DCIS.
- * Angioinvasion: No.
- * Perineural invasion: No.
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 7% of tumor cells (Allred score 4/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 35% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Right breast cancer, Slide revision:

- Invasive duct carcinoma G II, micropapillary type with focal DCIS.

IPT:

- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 4/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 35% of tumor cells.



Signature

Verified by :

DR.Menna Nabil



Patient Name	: الأستاذة / نعام جميل جبره	Request No.	: 13000995
Patient No.	: 27412092501548	Request Date	: 06/11/2023
Path No.	: 3910/23	Verification Date	: 19/11/2023
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, MRM specimen:

- * Invasive duct carcinoma GII with micropapillary features.
- Maximal tumor diameter 7.5x3.5 cm
- Actual tumor cellularity: 75%, tumor necrosis index: 25%
- * Minimal DCIS <5%.
- * Free nipple and areola.
- * Lymph nodes were positive in (11/21 with extracapsular extension).
- * Free deep margin.
- * Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT3, ypN3.
- RCB: 4.58 , RCB class III.

Signature

Prof. Dr. Lubna Omar.

Dr. Menna Nabil.

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 30/11/2023 11:25:40

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

الطبيب العام

مركز الرعاية الصحية

WE CARE SMARTLY

Name: En'aam Camil Gabra
Pat. Age: 45 Year(s)
Pat. ID: 1611674

Date: 06/05/2023

Dear Prof. Dr.:

Thank you for referring this case:

MDCT SCAN OF THE CHEST WITH CONTRAST REVEALED:-

- Known case of left breast cancer, the current study revealed:
- Left breast shows diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs , largest 22 mm .
- No pulmonary patches.
- No pulmonary consolidation, cavitary or infiltrative lesions.
- No pulmonary masses or sizeable nodules.
- Few basal linear thin atelectatic bands .
- No hilar or mediastinal masses or significant lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Patent trachea and major tracheo-bronchial airways.
- Intact bony thoracic cage.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No bony sclerotic or lytic bony deposits .

Opinion

- Known case of left breast cancer
- Left breast diffuse skin and subcutaneous tissue edema associated with multiple enlarged pathological enlarged LNs .
- No evidence of any thoracic organ deposits .
- Few basal linear thin atelectatic bands .

Much Obligated, Yours
Dr. Islam Salah, MD



Baheya Accredited
By Joint Commission International



بإسـمـه
05

مركز باهية لتشخيص الأمراض
وعلاج سرطان الثدي

18-Jun-2023 04:02 PM

PATIENT NAME: Naam GAMIL GABRA GRAS	PATIENT ID #: 10120227128
GENDER: Female	ORDER #: 2349040
AGE: 48 y	DATE OF SERVICE: 18-Jun-2023 04:02 PM

Report:

99mTc-MDP BONE SCAN

Desired Information: - skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP.

FINDINGS:

Degenerative changes at dorso- lumbar vertebrae.

Arthritic changes at knees and shoulders.

Otherwise, no hot or cold spots that would account for serious bone lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion: -

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

18-Jun-2023 03:56 PM

PATIENT: Naam GAMIL GABRA GRAS, 10123227128, Female, 48 y

Report version 1, 20-Jun-2023 01:46 PM

Page 1 of 1



Patient Name	: الأستاذ / نعام جميل جبره	Request No.	: 13000995
Patient No.	: 27412092501548	Request Date	: 06/11/2023
Path No.	: 3910/23	Verification Date	: 19/11/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 23x18x4 cm with covering skin ellipse measured 23x12 cm.
- * Tumor extent: A greyish white ruberry tumor bed site.
- * Size: 7.5 x3.5 x3 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 3 cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x6x2 cm, entangling 21 L.Ns up to 2x2 cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma with micropapillary features.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 7.5x3.5 cm
- Actual tumor cellularity: 75%, tumor necrosis index: 00%
- * Ductal carcinoma in situ: Minimal DCIS <5%.
- * Lymphovascular emboli: Occasional.
- * Skin involvement: Free nipple and areola.
- * Lymph node involvement: positive in (11/21 with extracapsular extension).
- * Resection Margins: Free deep margin.
- * Histologic response to therapy: partial pathological response.
- * Microcalcifications: yes.
- * Additional pathologic findings: Necrosis.

Verified by :

DR.Menna Nabil

